

Guía clínica: Depresión Mayor

El trastorno depresivo mayor (TDM) es una de las condiciones más prevalentes en consulta psicológica. Esta guía orienta la evaluación, conceptualización e intervención desde un marco clínico integrador.

1. Criterios diagnósticos centrales (DSM-5)

Presencia de 5 o más síntomas durante al menos 2 semanas, con al menos uno de los dos primeros:

- Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días.
- Pérdida marcada del interés o placer en todas o casi todas las actividades (anhedonia).
- Cambios significativos de peso o apetito.
- Insomnio o hipersomnia.
- Agitación o enlentecimiento psicomotor observable.
- Fatiga o pérdida de energía.
- Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva.
- Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.
- Pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida.

2. Presentación clínica: lo que no siempre aparece en el manual

Síntomas nucleares frecuentes	Presentaciones menos visibles
• Tristeza profunda o sensación de vacío.	• Irritabilidad (especialmente en jóvenes).
• Anhedonia: ya nada da placer.	• Síntomas somáticos sin causa médica.
• Fatiga que no mejora con el descanso.	• Ansiedad como síntoma predominante.
• Autocrítica intensa y culpa desproporcionada.	• Funcionamiento aparentemente normal ('depresión sonriente').

3. Modelo cognitivo de la depresión (Beck)

La tríada cognitiva negativa: visión negativa de uno mismo ('soy un fracaso'), del mundo ('nada tiene sentido') y del futuro ('las cosas nunca van a mejorar'). Estos pensamientos automáticos negativos se sostienen en creencias nucleares disfuncionales formadas a lo largo de la historia.

4. Factores de mantenimiento clave

- Inactividad y retirada social: rompe el acceso a refuerzos positivos (activación conductual).
- Pensamientos automáticos negativos y rumiación: amplían el estado de ánimo depresivo.
- Evitación emocional: no procesar el dolor lo perpetúa.
- Creencias nucleares de inutilidad, incapacidad o falta de amor.

- Factores interpersonales: pérdidas, conflictos, aislamiento.

5. Enfoques y técnicas recomendadas

Activación conductual	Primer paso. Aumentar actividades reforzantes antes de abordar cogniciones. Especialmente eficaz en fase aguda.
TCC clásica	Registro y cuestionamiento de pensamientos automáticos negativos. Experimentos conductuales. Reestructuración cognitiva.
ACT	Defusión cognitiva de la rumiación. Clarificación de valores. Acción comprometida a pesar del dolor.
IPT	Trabajo en duelo, transiciones de rol, déficits interpersonales. Muy indicada en depresión con componente relacional fuerte.
Mindfulness (MBCT)	Especialmente indicada en depresión recurrente. Prevención de recaídas. Descentramiento de los pensamientos depresivos.

6. Objetivos terapéuticos generales

- Reducir la intensidad y frecuencia de los episodios depresivos.
- Recuperar el acceso a actividades reforzantes y vínculos significativos.
- Identificar y modificar pensamientos automáticos negativos y creencias nucleares.
- Desarrollar estrategias de regulación emocional y prevención de recaídas.
- Fortalecer la autoestima y el sentido de eficacia personal.

Notas clínicas

Formulación del caso / hipótesis de mantenimiento:
Objetivos consensuados para las primeras sesiones: